

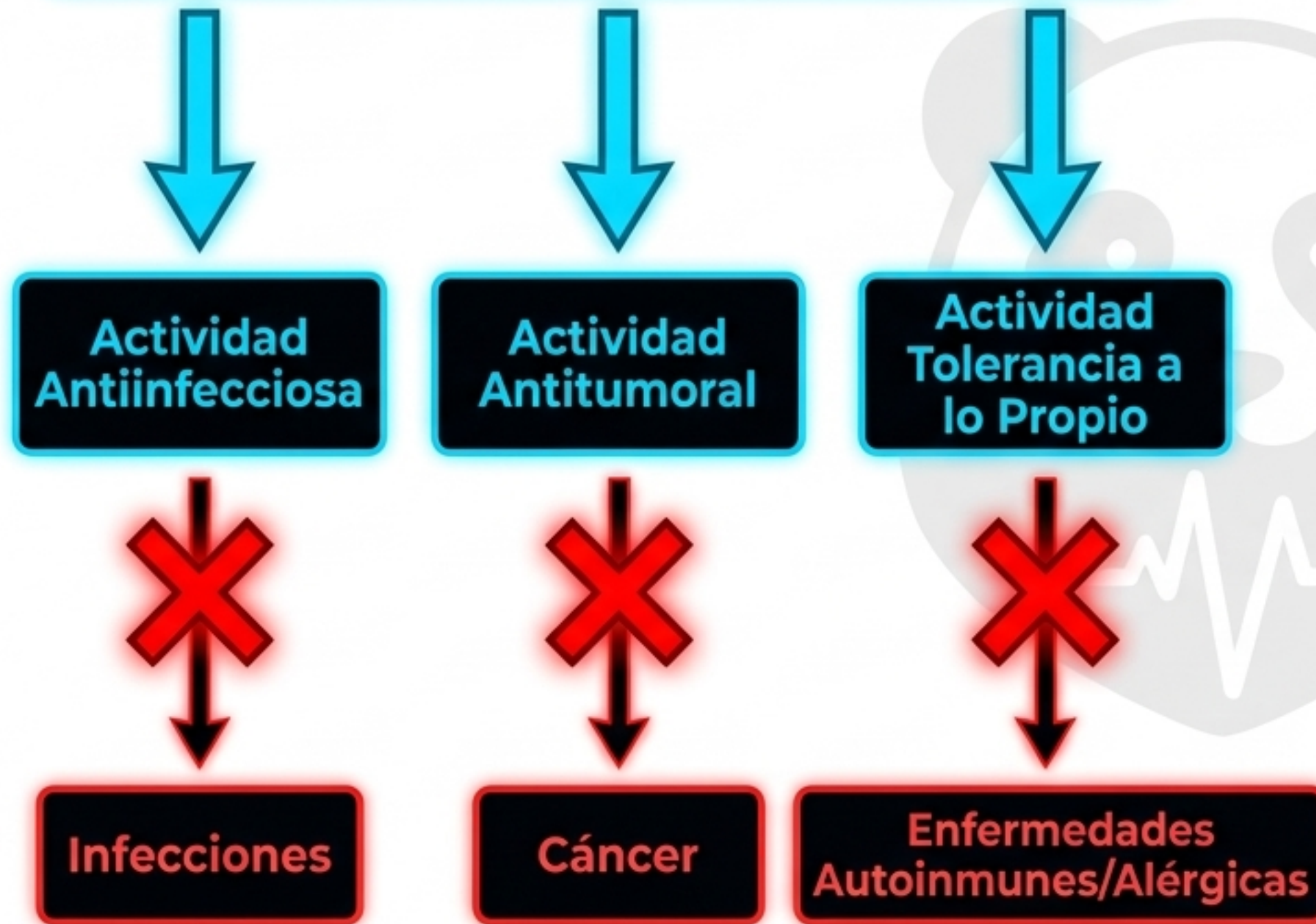
ENFOQUE CLÍNICO DEL PACIENTE FEBRIL

Guía de Estudio y Abordaje Diagnóstico

Módulo de Infectología



Actividades del Sistema Inmune



Principales Huéspedes Inmunocomprometidos

- + Neonatos y adultos mayores
- + Pacientes oncológicos y onco-hematológicos
- + Trasplantados (órganos sólidos, hematopoyéticos)
- + Quimioterapia y Radioterapia
- + Corticoterapia crónica y drogas inmunosupresoras
- + Enfermedades sistémicas (Diabetes Mellitus, ERC, Cirrosis, LES)
- + Malnutrición y quemados

BACTERIANO

- Fiebre Tifoidea, Brucelosis Aguda,
- Tuberculosis, Bartonelosis (Enf. de Carrión), Leptospirosis, Sepsis,
- Endocarditis Infecciosa,
- Abscesos Intraabdominales,
- ITU Alta.

VIRAL

Infeccioso

- VIH (Primaria), VHB,
- Rubéola, CMV, Mononucleosis Infecciosa.

No Infeccioso

- RAM, Linfoma Maligno.

PROCESO INFECCIOSO GENERALIZADO

PARASITARIO

- Toxoplasmosis Aguda,
- Malaria,
- Sepsis.

FÚNGICO

- Fungemias,
- Sepsis.

qSOFA Score



1

**FR
≥ 22 x
minuto**

2

**Estado
mental
alterado
(Glasgow
< 15)**

3

**PAS
≤ 100
mm Hg**

15%

SRIS vs. qSOFA

**SRIS: Mayor
sensibilidad.**

**qSOFA: Aumenta la
especificidad para
mortalidad y predicción
de disfunción orgánica.**

Nidos de Infección

1. Urinario

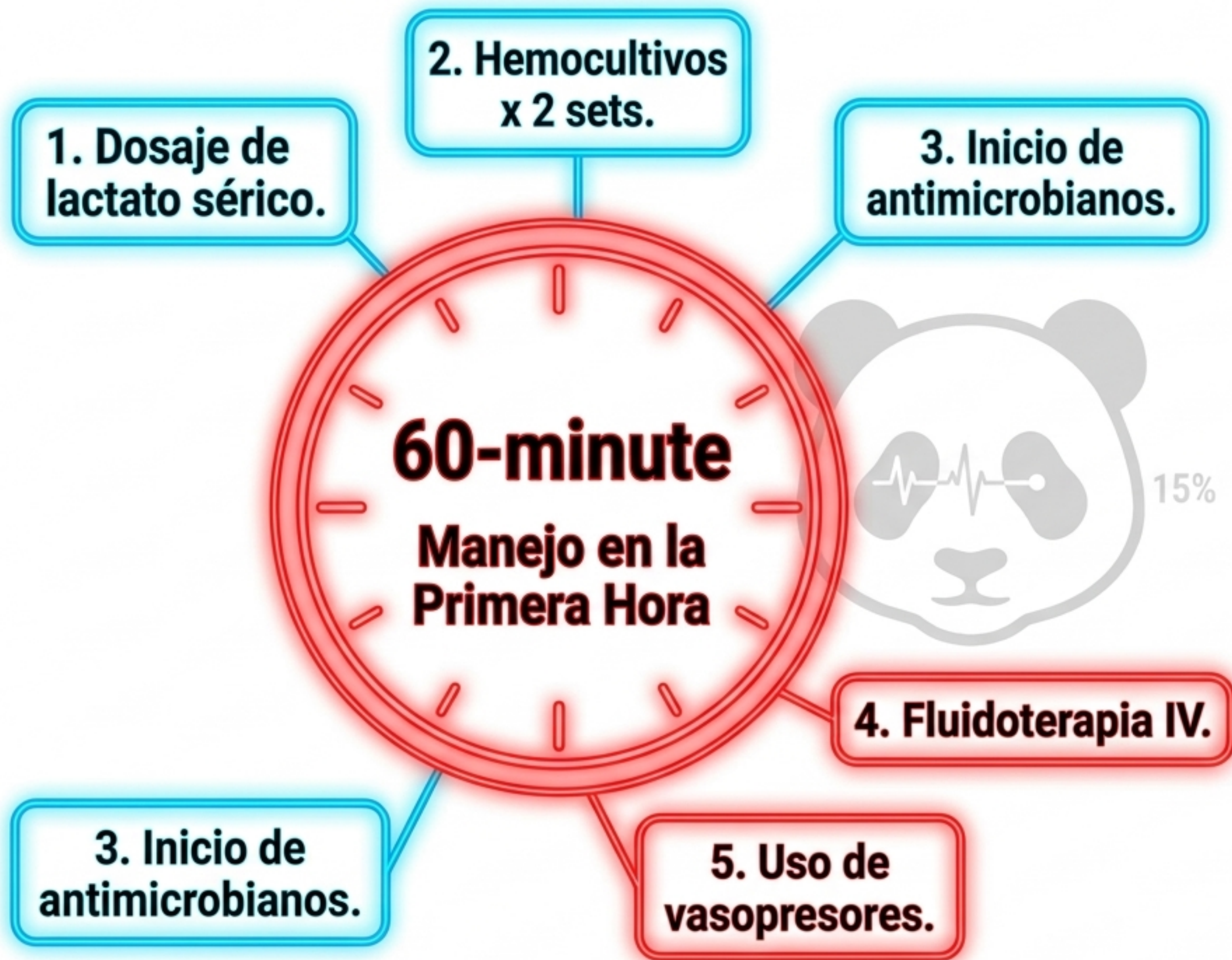
2. Pulmonar

3. Cutáneo

4. Abdominopélvico

Simuladores de Sepsis (No Infecciosos)

Cardiovascular	Disritmia, TEP, IAM, Insuficiencia cardíaca, Edema agudo de pulmón
Endocrino	Cetoacidosis diabética, Tormenta tiroidea, Pancreatitis, Insuficiencia suprarrenal
Respiratorio	Aspiración masiva, Atelectasia
Toxicológico	Intoxicación, Síndrome serotoninérgico, Abstinencia de alcohol



Pilares de Soporte

- Respiratorio
- Cardiovascular (Hemodinámico)
- Hídrico/Metabólico
- Nutricional
- Psicológico

Fiebre en Neutropenia



← $T^{\circ} \geq 38.3^{\circ}\text{C}$ oral
(en una sola toma).

← $T^{\circ} \geq 38.0^{\circ}\text{C}$ oral
(2 controles en 1 hora).

Clasificación Cuantitativa (Neutrófilos/ mm^3)

< 1,000:
Significativa.

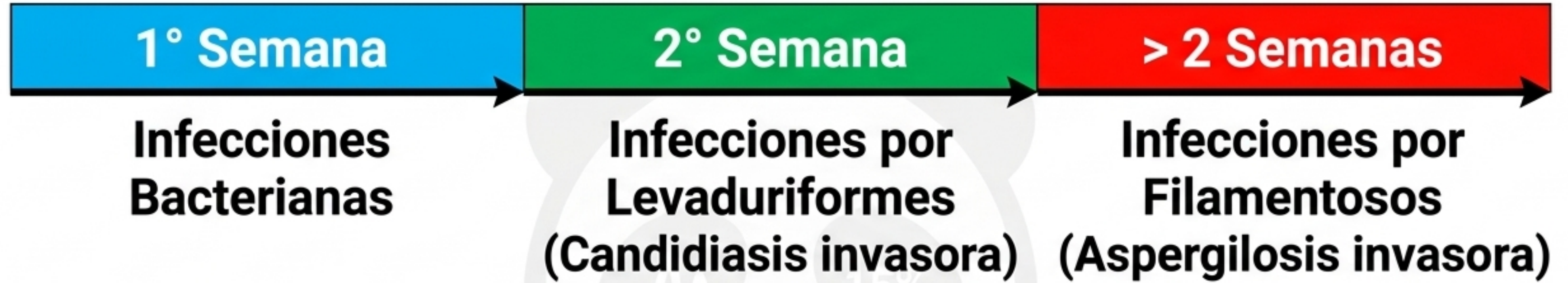
≤ 500 : Severa o Grave
($\geq 60\%$ origen infeccioso
si hay fiebre).



< 1,500: Neutropenia
general.

≤ 100 : Muy Severa o
Profunda
($\geq 20\%$ bacteremia).

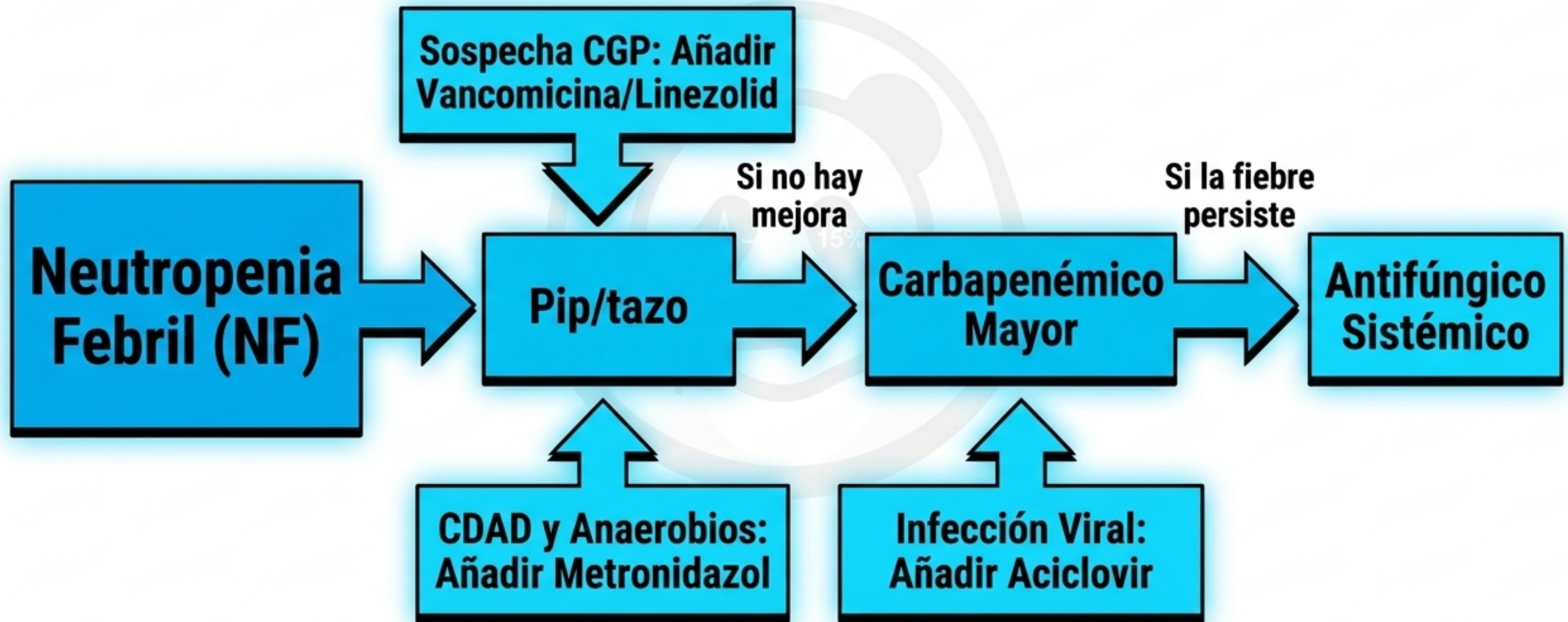
Cronología del Riesgo de Infección en Neutropenia



Focos Clínicos Principales	Documentación Diagnóstica
Tracto aéreo-digestivo, Sanguíneo, Pulmonar, Cutáneo.	• Microbiológica: 30% • Clínica: 20% • Solo fiebre / FOD: 50%

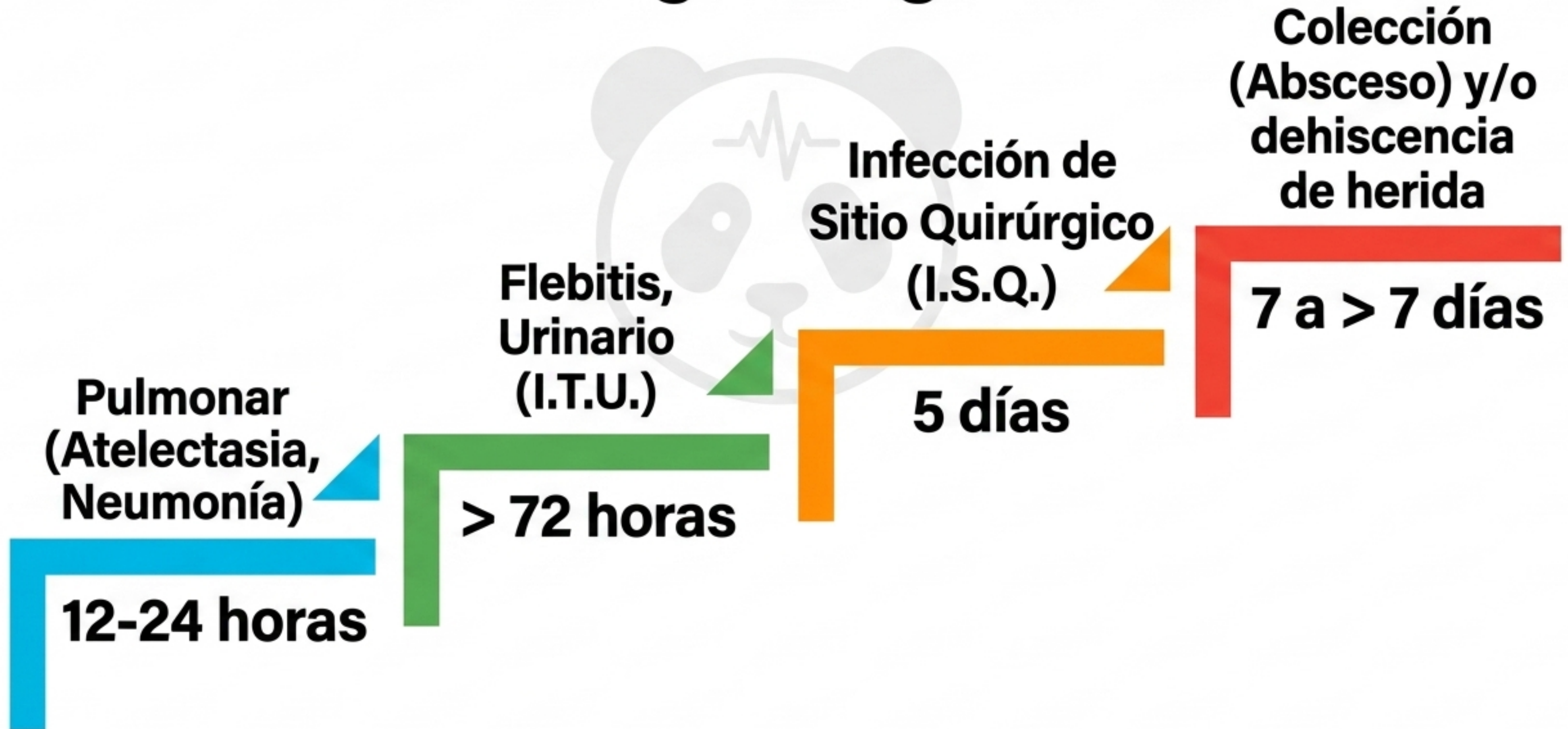
¿Emergencia Oncológica?

Inicio en 1ra Hora. (Demora 24h = >50% mortalidad; 48h = >80% mortalidad).

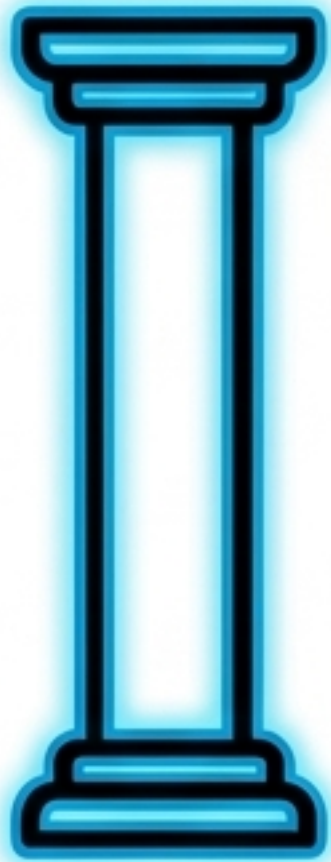


Fiebre Postoperatoria: Cronología Diagnóstica

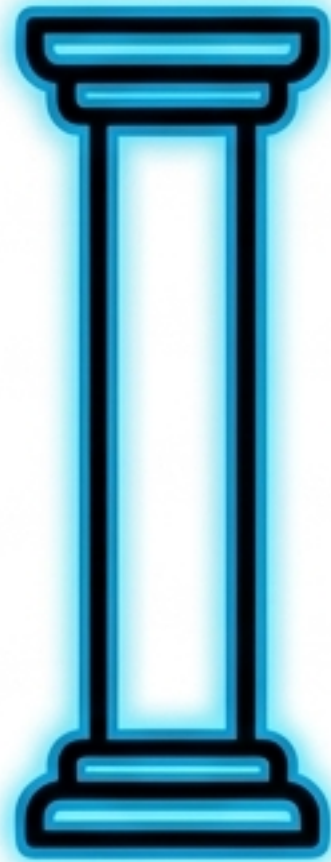
Definición:
 $T^{\circ} \text{ Rectal} > 37.8^{\circ}\text{C}$



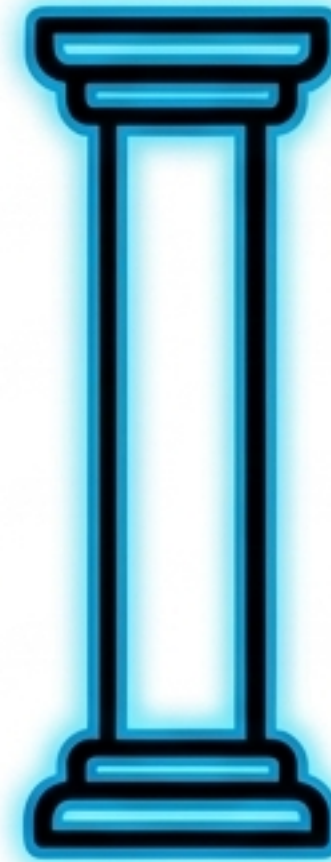
Fiebre de Origen Desconocido (FOD): Criterios Clásicos



**1. Temperatura
> 38.3 °C
(comprobada en
diversas
ocasiones).**



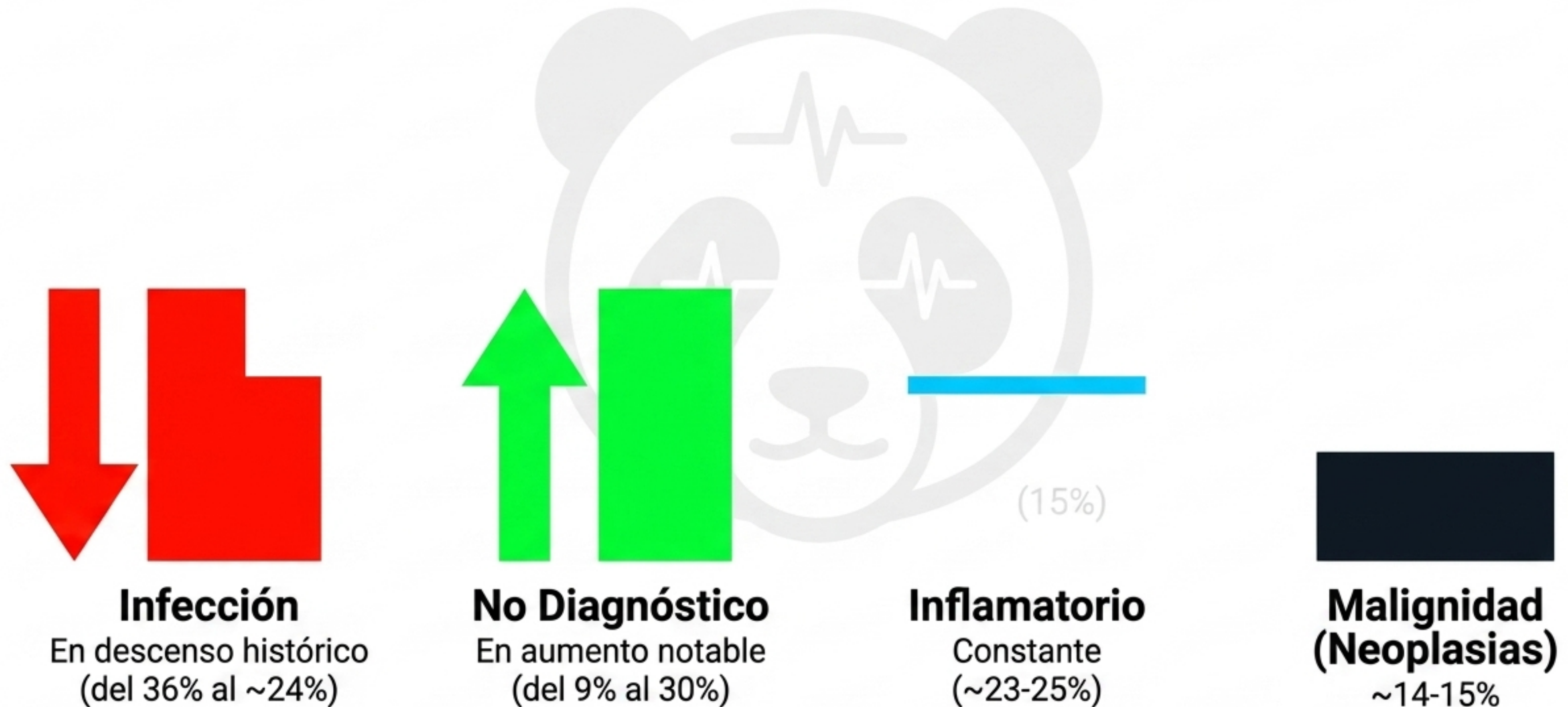
**2. Duración >
3 semanas.**



**3. Ausencia de
diagnóstico (pese a
1 semana de estudio
intrahospitalario o
intensivo
ambulatorio).**

“Generalmente la FOD es debida a una enfermedad común con presentación atípica, más que a una enfermedad rara con presentación típica.”

FOD: Espectro Etiológico Histórico



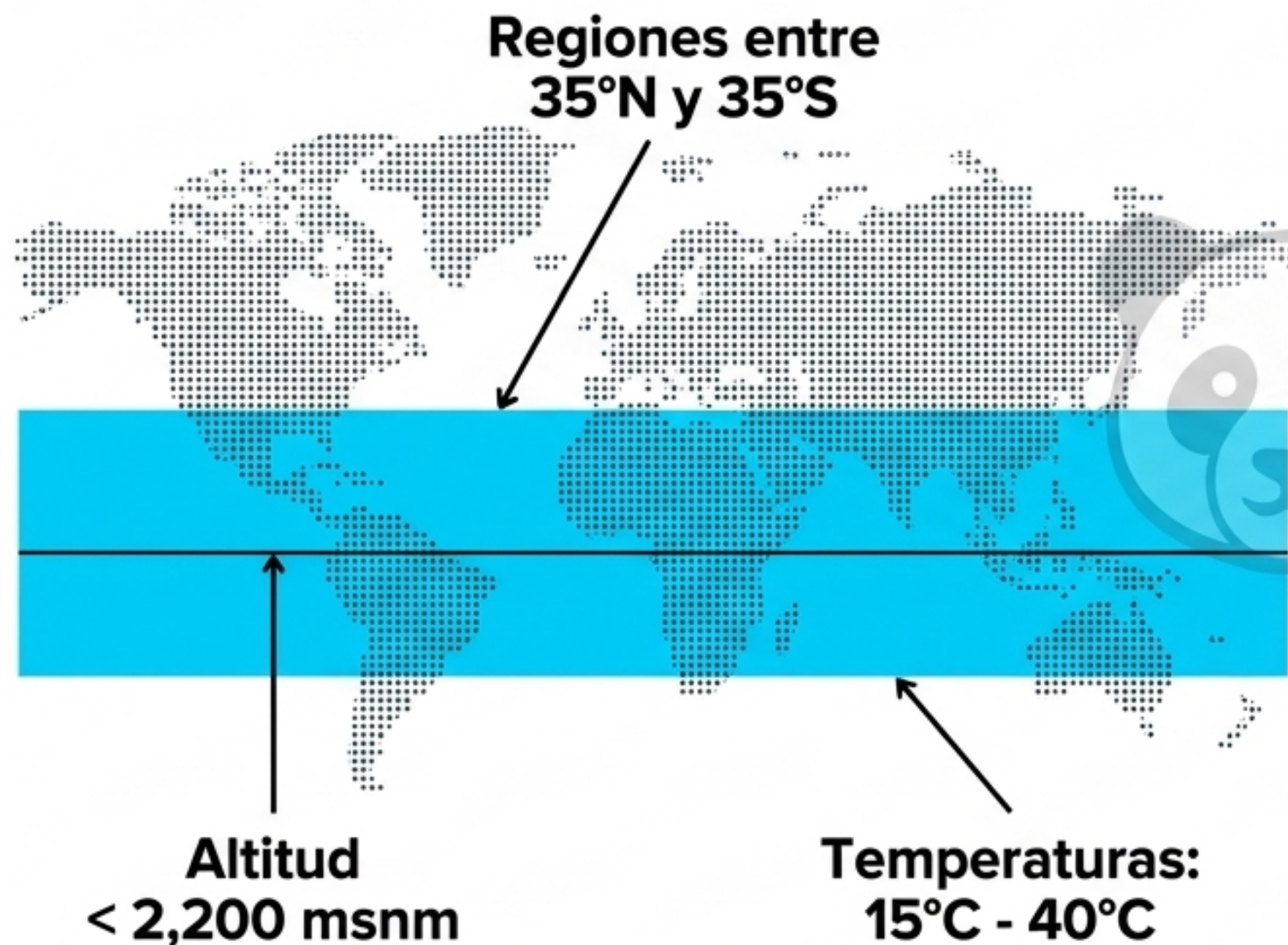
FOD: Protocolo Diagnóstico y Rendimiento



Rendimiento Diagnóstico de Pruebas Clave

Biopsia 25.0%	Historia y evolución clínica 23.0%
Cultivos y serología 13.0%	TAC / Resonancia 6.3%

Síndrome Febril Agudo: Enfermedades Tropicales Desatendidas (NTDs)



13 enfermedades = 57 millones DALYs

>90% de la carga proviene de:

- Ascariasis, Trichuriasis, Nemátodes,
- Schistosomiasis, Filariasis linfática,
- Tracoma, Oncocerciasis.

Categoría 1 (Emergente/No controlada)	Categoría 3 (Plan de eliminación)
Ej. Leishmaniasis, Dengue	Ej. Lepra, Oncocerciasis

1. Megaciudades
(Aumento notable
de población)

2. Migraciones
(Crisis, guerras)

**3. Cambios
Ecológicos**
(Deforestación,
ej. Amazonía)

**4. Viajes
Internacionales**

**5. Comportamiento
Sexual** (Cambios
transculturales)

**6. Tecnología de
Alimentos**
(Nuevos vectores
de consumo)

**El Origen del
Problema:
Infecciones
Emergentes,
Re-emergentes
y Nuevas**